

E Q U I L I B R I O

Quando la pornografia smette di essere un passatempo

*Guida di autovalutazione per uomini
che vogliono capirci qualcosa prima di decidere*

Dott. Ivan Ferrero

Psicologo psicoterapeuta

Iscritto all'Albo degli Psicologi della Lombardia n. 03/16571 dal 06/06/2003

<https://equilibrio.ivanferrero.it/>

ivan@ivanferrero.it

Edizione 2026

INDICE

Le tappe del cammino

Apertura.....	3
Parte I — Lo specchio: ti ci riconosci?.....	5
Parte II — Il ciclo dell'utilizzo compulsivo della pornografia online.....	9
Parte III — Perché hai già provato e non ha funzionato.....	14
Parte IV — Cosa succede nel corpo.....	18
Parte V — Le cinque domande di un percorso.....	23
Parte VI — E adesso cosa faccio.....	27
Parte VII — Ponte: e se il porno con me non c'entra?.....	31
Parte VIII — Passaggio di testimone.....	34
Appendici.....	36

APERTURA

Apertura

Nota al lettore

Prima di iniziare ti devo dire tre cose brevi.

La prima riguarda il "tu" che incontrerai da qui in avanti. È un "tu" personale, non clinico. È tarato su chi sta vivendo in prima persona quello di cui parlo, cioè, nella stragrande maggioranza dei casi, su un uomo adulto. Se sei una donna che sta leggendo questa guida per un uomo che ami, molto di quello che troverai vale comunque, ma sappi che non ho calibrato io il linguaggio sulla tua posizione. Se sei un'altra figura interessata al tema (un collega, un educatore, un familiare diverso da una compagna), la stessa avvertenza vale per te. Ti chiedo di tenerlo presente mentre leggi, perché in alcuni passaggi il "tu" suonerà molto vicino alla pelle, e quella vicinanza non è un caso.

La seconda riguarda Marco, il protagonista che incontrerai tra poche righe. Marco è un caso composito. Nessuna persona reale è riconoscibile nella sua storia. Ho costruito la sua biografia mettendo insieme elementi ricorrenti che ho incontrato, negli anni, in molti percorsi clinici: l'età intorno ai quaranta, una professione qualificata, una vita coniugale con figli, un lungo arco di uso problematico, due tentativi di smettere finiti come di solito finiscono. Nessuno di questi elementi è preso da una singola persona. Messi insieme raccontano un pattern che si ripete, non una semplice biografia, e forse parlano anche di te.

La terza riguarda cosa è e cosa non è questo testo. Questa guida non costituisce una diagnosi e non sostituisce una valutazione clinica. Ti consegna una mappa. La mappa serve a orientarsi, non a coincidere con il territorio. Camminare nel territorio, quando arriva il momento di farlo, è un'altra cosa, e si fa con qualcuno che lo conosce, sia io o sia un collega qualificato.

Indice narrativo

Otto tappe, una frase ciascuna, perché tu sappia dove stiamo andando.

I. Lo specchio. Il momento, raro e prezioso, in cui ci si vede dal di fuori mentre si sta facendo la cosa, e perché quel momento conta più di "smettere".

II. Il ciclo. Il meccanismo a quattro tempi che regge il comportamento, disegnato in modo che tu possa riconoscerlo nella tua vita e non solo a parole.

III. Perché hai già provato e non ha funzionato. La differenza tra affrontare il sintomo e affrontare il meccanismo, e cosa dice la ricerca su NoFap, reboot e dintorni.

IV. Cosa succede nel corpo. Come uno stimolo costruito per superare ogni stimolo naturale ricalibra il sistema, perché il PIED esiste e perché un lavoro fatto solo con la testa, di solito, non basta.

V. Le cinque domande di un percorso. Le cinque domande a cui un lavoro clinico serio risponde in sequenza, scritte con parole vicine alle tue.

VI. E adesso cosa faccio. Tre azioni ragionevoli che puoi iniziare domani senza chiamarle terapia, e cosa aspettarsi nei giorni successivi alla lettura.

VII. E se il porno con me non c'entra. Quattro criteri brevi per capire se questa è la mappa giusta per te o se ti riguarda un altro scenario, in due pagine.

VIII. Passaggio di testimone. Cosa ti arriverà nelle tre settimane dopo questa lettura, cosa non ti arriverà, e perché ho scelto di costruire le cose in questo modo.

Parte I — Lo specchio: ti ci riconosci?

Marco, venerdì sera

Ti ci riconosci?

Marco ha quarantadue anni. È venerdì. In casa c'è il tipo di silenzio che si sente solo quando tutti quelli che ami stanno respirando piano nelle altre stanze. Moglie a letto, figli a letto. Lui è al tavolo della cucina, con il laptop davanti e la tazza di tisana che si è raffreddata da mezz'ora.

La settimana scorsa aveva deciso che avrebbe smesso.

Non lo aveva deciso di impeto. Non dopo una litigata, non in uno di quei momenti in cui uno si ripromette qualcosa sapendo già di non mantenerlo. Aveva ragionato. Era arrivato a quella decisione camminando, una mattina, mentre andava al lavoro. L'aveva scritta perfino in una nota sul telefono, breve, asciutta, come una cosa seria.

Eppure eccolo qui.

Il laptop aperto, la mano sul touchpad, il browser a un clic dalle pagine di sempre.

Si ferma un istante. È un istante piccolo, di quelli che normalmente saltiamo, che normalmente non sono neanche un istante, sono solo il vuoto tra due gesti che facciamo senza accorgercene.

In quel vuoto, stasera, succede qualcosa che non gli era mai successo in quindici anni.

Riconosce il gesto.

Non come peccato. Non come debolezza. Non come il solito "dai, l'ultima volta, poi giuro che basta". Come automatismo. Come una sequenza di comandi che il suo corpo ha imparato così bene da eseguirla senza chiedere il permesso a nessuno, men che meno a lui.

Chiude il laptop. Non per virtù. Per stupore.

È la prima volta in quindici anni che Marco si vede dal di fuori mentre sta facendo la cosa.

Questa guida parla di quell'istante.

Non di come smettere. Di come riconoscere. La differenza è più grande di quanto sembri, e la maggior parte del lavoro clinico che faccio con uomini come Marco, e probabilmente come te, si costruisce esattamente lì dentro. In quel vuoto tra due gesti che di solito è invisibile e che, ogni tanto, per ragioni a volte banali a volte misteriose, si apre.

Non sei un caso raro

Prima di andare avanti, voglio metterti in mano un dato. Non per rassicurarti, perché la rassicurazione da sola non fa niente. Per darti coordinate.

Oltre il 60% dei giovani adulti italiani consuma regolarmente pornografia online. È una maggioranza. Se diluisci quel numero su una generazione intera, smette di essere una statistica e diventa quello che succede in una percentuale molto alta dei venerdì sera di questo paese. Tu, qualunque cosa tu stia pensando di te in questo momento, non sei lontano da una maggioranza. Ci sei dentro, a pieno titolo, insieme a milioni di altri uomini che stanno facendo la stessa cosa nella stessa ora.

Di questa maggioranza, una quota che la ricerca stima tra l'1 e il 3% sviluppa un uso compulsivo, con impatto funzionale misurabile. Impatto funzionale significa che qualcosa ne risente, e in modo osservabile, non immaginato: il sonno, il lavoro, la sessualità con una partner reale, la qualità dell'attenzione, il tempo, il denaro, il corpo. In una città italiana di mezzo milione di uomini adulti, stiamo parlando di cinquemila-quindicimila persone. Sono tante. Ma il fatto che siano tante non toglie niente alla sofferenza di una sola di loro, e non toglie niente alla tua. Il dato di prevalenza non serve a relativizzare quello che stai vivendo. Serve a dirti una cosa diversa: questo territorio è già stato percorso. C'è una letteratura clinica, ci sono protocolli, ci sono professionisti che ci lavorano da anni. Non sei su un sentiero tuo. Qualcuno è passato di qui prima di te, e in questa guida te lo mostro.

Un'ultima cifra che voglio darti, perché parla di un pezzo di storia recente che probabilmente hai vissuto anche tu. Durante la pandemia di COVID-19, in Italia, le iscrizioni a siti di incontri per persone sposate sono aumentate del 300%. Non te lo sto raccontando per fare moralismo, e neanche per spaventarti. Te lo dico perché se in quel periodo tu hai aperto siti di quel tipo, o chat, o profili paralleli, non sei stato un caso isolato. Se ti sei chiesto "ma cosa diavolo sta succedendo a me", una parte della risposta è banale: stava succedendo a moltissimi uomini, contemporaneamente, nel collasso del ritmo ordinario di due anni molto strani. Una parte, tieni presente. L'altra parte, la parte che riguarda il perché proprio tu e non il tuo vicino di casa, è tua, ed è il motivo per cui ha senso guardarla.

Sono solo numeri, ma un numero, a volte, fa più compagnia di mille assicurazioni, e tutto per questo per dirti, lo ripeto: tranquillo, non sei da solo.

Non è quante volte. È cosa succede intorno

E poi c'è questa idea, e la trovi dappertutto, nei forum, negli articoli veloci, nei pensieri che ti fai da solo la sera: conta quante volte. Più volte uguale più grave, meno volte uguale meno grave.

Non è così. La frequenza, da sola, non è il dato clinico.

Il dato clinico è cosa succede intorno a quelle volte.

Te lo mostro con tre uomini, in tre case diverse, stessa sera.

Il primo uomo ha quarantacinque anni. Lo fa due volte a settimana, da anni. Dorme bene. Lavora bene. Ha una sessualità regolare con sua moglie, che sa e non se ne preoccupa. Nei ritagli di tempo gioca con i figli e non pensa alla cosa. Due volte a settimana è, per lui, una funzione sessuale ordinaria, indipendente da qualunque sofferenza. Non c'è un problema.

Il secondo uomo ha quarantacinque anni. Lo fa due volte a settimana. Ma da tre mesi non si avvicina più a sua moglie. La sera aspetta che si addormenti, anche le sere in cui lei aveva provato, con poche parole, a cercarlo. Quando lei lo tocca sulla spalla, lui trova una scusa onesta, perché è davvero stanco, ma la stanchezza copre qualcos'altro che lui stesso fatica a guardare. Due volte a settimana. Stessa cifra del primo uomo. Altro pianeta.

Il terzo uomo ha trent'anni. Lo fa ogni sera da quando ne aveva ventidue. Non ha mai avuto una disfunzione. Non ha mai saltato un appuntamento né compromesso una relazione. Nei suoi rapporti sessuali sta dentro, in contatto, presente. Sette volte a settimana. Nessun problema clinico identificabile.

Tre frequenze, tre significati diversi. Il numero da solo non parla.

Quello che parla è altro. Cosa stai cercando quando lo fai: piacere, rilassamento, spegnimento di un'emozione, evasione da qualcosa di più grande che non vuoi guardare stasera. Come stai dopo: neutro, scarico, in colpa, vuoto, irritato con te stesso. Chi e cosa tolgono quelle ore a te e a chi ti sta accanto: sonno, attenzione, presenza, desiderio per una persona reale, tempo che avresti potuto dare a qualcosa che ti importava. Se ci hai provato a ridurre, e soprattutto cos'è successo quando ci hai provato. Se c'è qualcuno, nella tua vita, che sa davvero quanto usi. Queste sono domande cliniche. La frequenza, da sola, è solo una domanda statistica.

Se mentre leggi ti stai dicendo "ma allora magari io sono il primo caso, ci sto dentro", è un pensiero lecito. È anche il pensiero che con ogni probabilità tornerà con più forza tra due o tre giorni, quando avrai chiuso questa guida e sarai tornato alla tua vita. È la voce che ti dirà che forse non era così grave, che ti sei riconosciuto troppo, che puoi chiudere qui (in letteratura clinica si chiama minimizzazione post-riconoscimento). È la prima delle resistenze che incontra chi legge qualcosa come quello che hai appena letto, ed è la più fisiologica e la più depotenziante, se non la si vede arrivare.

Questo punto lo riprenderemo la prossima settimana, quando ti scriverò, e lo guarderemo insieme da dentro. Andremo avanti, perché c'è una cosa che voglio mostrarti nelle prossime pagine, e riguarda un ciclo che probabilmente conosci già, ma che nessuno ti ha mai disegnato davanti.

Parte II — Il ciclo dell'utilizzo compulsivo della pornografia online

Il ciclo in quattro tempi

Prima del riconoscimento c'è il meccanismo. Prima di parlare di cosa farne, ha senso disegnarlo.

Il ciclo si articola in quattro tempi, con una coda che non è un quinto tempo a sé, è il punto in cui il ciclo rientra su se stesso, più veloce di prima.

Primo tempo. Un trigger, non sempre erotico: più spesso stress, solitudine, stanchezza, un conflitto non detto con qualcuno che ti sta accanto, un'emozione che non riesci a mettere in parola nel momento in cui arriva.

Secondo tempo. L'uso, di durata variabile, in cui il sistema nervoso sta cercando un'uscita da un'attivazione che non sa gestire altrimenti.

Terzo tempo. Il sollievo chimico, strutturalmente breve, perché la chimica della ricompensa ha una curva rapida che sale e scende in fretta, e il sistema torna alla base prima di quanto ti aspetti.

Quarto tempo. Vergogna e vuoto, spesso mescolati a un sollievo residuo che non li contraddice ma li rende più confusi, ed è in quel misto di sensazioni contraddittorie che di solito non rimani a lungo.

A quel punto il ciclo non si chiude, si riapre. Il trigger, alla prossima occasione, non è più quello di partenza. Si è ingrossato del residuo del ciclo precedente. Ciò che era stress da lavoro, ora è stress da lavoro più il peso di ieri sera. Ciò che era solitudine, ora è solitudine più la vergogna di come hai gestito la solitudine l'ultima volta. Il ciclo si amplifica da sé, senza che nessun evento esterno stia peggiorando la tua vita.

Questo è, in sintesi, quello che in clinica chiamiamo un ciclo di dipendenza comportamentale a rinforzo negativo. Non è una diagnosi che ti sto facendo, è il nome di una forma. Le forme si studiano e, quando le si vede, si possono interrompere.

Il punto più importante di questa pagina è uno solo: il terzo tempo, il sollievo chimico, non è il nemico. È la funzione del comportamento, quello che il sistema nervoso sta cercando di ottenere in quel momento. Lavorare sul quarto tempo, la vergogna, senza aver capito cosa il sistema stava cercando nei tempi precedenti, è come mettere una toppa al buco sbugliato di una camera d'aria. L'aria continua a uscire da un'altra parte.

Perché il porno di oggi non è il porno di vent'anni fa

A questo punto è legittimo chiederti una cosa. Se questo meccanismo esiste, se è descrivibile, e se il porno esiste in qualche forma da molto prima di noi, come mai se ne parla clinicamente solo negli ultimi quindici o vent'anni. Cosa è cambiato.

È cambiato lo stimolo. È cambiato abbastanza da rendere inutili la maggior parte dei paragoni con la sessualità e con il porno di prima.

Tre cose, in particolare.

La prima si chiama supernormalità. È un concetto che in origine arriva dall'etologia: quando un animale è esposto a uno stimolo artificiale più intenso di quello naturale che ha imparato a riconoscere, risponde più allo stimolo artificiale che a quello vero. Il pulcino segue il becco di cartone dipinto in modo marcato più volentieri di quello reale della madre. Noi non siamo pulcini, ma il principio vale anche per noi, su stimoli di altro tipo. Il porno contemporaneo è costruito, sistematicamente, per essere uno stimolo sovradimensionato rispetto a qualunque esperienza sessuale naturale possibile. Corpi selezionati, scene coreografate, reazioni recitate, inquadrature irriproducibili nella vita reale, colonna sonora tagliata al minuto. Non è sesso filmato, è sesso iperamplificato da un'industria che ha avuto decenni per ottimizzarlo. A forza di guardarlo, il nostro sistema nervoso e cognitivo smette di calibrarsi sulla realtà e inizia a calibrarsi su quella forma di stimolo.

La seconda si chiama infinita novità. Ogni click un contenuto diverso. Ogni ricerca uno scenario nuovo. Il cervello, dal punto di vista evolutivo, non ha mai incontrato niente di simile nella sua storia. La novità è uno dei più potenti attivatori del sistema di ricompensa, perché è la variabile che il cervello ha imparato a trattare come informazione importante da esaminare. Un sistema nato per attivarsi davanti al nuovo, messo davanti a una sorgente di novità infinita, non ha freni nativi. Se deve premere uno stop, quello stop deve arrivare da fuori. Non può arrivare dal sistema, perché il sistema, quando è acceso, non sa di doversi spegnere.

La terza è l'accessibilità senza attrito. Fino a vent'anni fa, anche con l'intenzione più forte, tra te e quel materiale c'erano ostacoli pratici: un'edicola, un videoclub, un movimento fisico

per arrivare in edicola, una soglia sociale, il rischio di essere visti. Oggi tra il pensiero e la visione ci sono due secondi e un gesto del pollice. Quella soglia non è solo una comodità, è un elemento che cambia la natura del comportamento. Meno attrito significa meno tempo perché il pensiero razionale intervenga e contraddica l'impulso. Significa anche che quello che prima richiedeva di rompere una routine, adesso può infilarsi dentro una routine, in qualunque pausa di dieci minuti della giornata.

Park e colleghi, in una revisione pubblicata nel 2016 su Behavioral Sciences, hanno documentato in modo sistematico come questa combinazione di supernormalità, novità e accesso immediato sia associata a un insieme di disfunzioni sessuali emergenti negli uomini giovani, in particolare la disfunzione erettile porn-induced, su cui torneremo più avanti in questa guida. La conclusione operativa, per te che stai leggendo, è semplice. Se hai la sensazione che il porno di oggi abbia una presa su di te sproporzionata rispetto a quella che aveva su uomini di generazioni precedenti, non è una tua impressione. È una caratteristica dello stimolo, non una misura della tua volontà, e neanche la misura della tua forza interiore.

I quattro segnali

Con il ciclo visto dall'esterno e con una prima idea di perché questo specifico stimolo è potente, possiamo passare a una domanda che molti di voi si stanno già ponendo. Come capisco, senza farmi una diagnosi da solo, se il mio uso è funzionale o problematico.

Ti offro quattro segnali. Non sono un test, non ti danno un punteggio. Sono quattro punti di osservazione che usiamo in clinica, con sfumature e adattamenti, per capire dove siamo.

Il primo è l'impatto funzionale. L'uso sta togliendo qualcosa di riconoscibile a un'area concreta della tua vita. Il sonno, perché resti sveglio la notte più di quanto vorresti. Il lavoro, perché in ufficio apri schede che non dovresti aprire, o perché sei stanco la mattina in modo non proporzionato. Le relazioni, perché un pezzo di tempo che andava ad altri finisce lì. La sessualità reale, perché qualcosa si è fatto più difficile, o meno presente, o meno sentito. L'impatto funzionale non è una sensazione interna, è un fatto osservabile, dentro di te o intorno a te.

Il secondo sono i tentativi falliti di ridurre. Hai mai provato a diminuire? Quante volte? Per quanto tempo sei durato? Cosa ti ha riportato indietro? Un tentativo e una ricaduta non sono, da soli, un segnale clinico. Più tentativi, tutti simili, tutti finiti allo stesso modo, cominciano a esserlo. Non perché tu sia debole. Perché ogni ripetizione dello stesso fallimento suggerisce che la variabile che stai cercando di modificare non è quella giusta.

Il terzo è l'uso del materiale pornografico per regolare stati emotivi negativi. Se guardando il ciclo della pagina precedente hai riconosciuto che quasi sempre il tuo trigger non è erotico, ma è stress, solitudine, ansia, rabbia, noia, allora il porno sta svolgendo per te una funzione che non è la funzione per cui nasce. Sta facendo il lavoro di un regolatore emotivo di emergenza. Nella mia pratica, è il segnale più frequente nel gruppo di uomini che seguo.

Il quarto è il disallineamento tra comportamento e valori autodichiarati. Questa è la variabile più delicata, perché qui non ti sto parlando di morale esterna, ti sto parlando di quello che tu stesso hai dichiarato, a te e alle persone che ami, di voler essere. Se l'uso contraddice costantemente l'immagine di te che tu stesso porti avanti, questo dato è un segnale, non perché il comportamento sia sbagliato in assoluto, ma perché stai vivendo una frattura tra parti di te che non riesci a comporre. Un avviso: questo segnale, da solo, non fa diagnosi. Serve insieme agli altri, e serve letto con onestà. Altrimenti diventa una forma di auto-condanna che non aiuta nessuno.

I quattro segnali, letti insieme, funzionano come una bussola grossolana. Uno solo non dice niente di definitivo. Due presenti insieme iniziano a dire qualcosa. Tre o quattro presenti in modo stabile nel tempo sono l'indicazione che ha senso guardare la questione sul serio, con qualcuno che sia in grado di guardarla con te.

Dieci domande

A questo punto, prima di chiudere questa parte, ti chiedo una pausa.

Quello che segue è un insieme di dieci domande. Non hanno un punteggio. Non c'è una soglia che definisce un problema. Non devi rispondere per iscritto, se non vuoi. Non devi rispondere adesso, se non te la senti. L'unica cosa che ti chiedo è di fermarti su ciascuna il tempo necessario perché la risposta, nella tua testa, prenda forma.

DIECI DOMANDE PER TE

Quanto tempo passa, in un giorno tipico, tra il momento in cui ti svegli e il primo pensiero, o la prima azione, legata al porno o a stimoli simili?

Quando hai provato a ridurre, quanto sei durato prima di rientrare nel comportamento?

Quali emozioni, più delle altre, precedono l'uso?

Come stai subito dopo. E come stai due ore dopo?

Cosa hai smesso di fare, o cosa hai smesso di chiedere, a qualcuno che ti sta accanto, da quando il tuo uso è così?

C'è qualcuno, nella tua vita, che sa davvero quanto usi questo materiale?

Se togliessi il porno stasera, cosa resterebbe al posto suo?

C'è una fascia oraria della settimana, o un luogo, in cui ti senti più esposto all'impulso di usare, anche quando avevi deciso di non farlo?

Se un amico che stimi ti raccontasse a metà voce quello che stai leggendo di te stesso in questa pagina, come gli risponderesti?

Cosa ti hanno detto di te le risposte a queste domande, al di là delle parole che hai usato per formularle?

Se rispondere a queste domande ti ha messo in movimento qualcosa, fermati un momento. Se una sola ha smosso più delle altre, è un'informazione. Se rileggendole domattina ti verrà voglia di negarle un po', è un'informazione anche quella.

Ricorda che questa guida non serve a convincerti di nulla. Serve a restituirti uno spazio di osservazione che forse non hai, perché la vita ti porta a correre, e perché questo tema, nella cultura in cui siamo cresciuti, è esattamente il tipo di tema su cui non ti è concesso rallentare. Qui, per venti pagine ancora, puoi.

Parte III — Perché hai già provato e non ha funzionato

Il tentativo fallito è la regola, non l'eccezione

C'è una cosa che succede quasi sempre, quando un uomo si siede nel mio studio per la prima volta per parlare di questo tema. A un certo punto, solitamente già nella prima o nella seconda seduta, mi racconta che ci ha già provato.

Non è un'eccezione. È la regola: prima o poi accade.

Te lo sto dicendo perché la maggioranza degli uomini che arrivano da me ha già fatto almeno un tentativo di smettere da solo, spesso più di uno, prima di decidere che vale la pena pagare qualcuno per parlarne. Alcuni hanno provato con la forza di volontà pura, convincendosi che bastasse decidere. Altri hanno seguito programmi strutturati di astinenza trovati online, in comunità che si danno un nome, un conteggio dei giorni, un lessico. Altri hanno installato app di blocco sul telefono, filtri sul router, promemoria sul calendario. Altri ancora hanno provato a coinvolgere la partner, chiedendole di controllare la cronologia, di avere la password del telefono, di essere la soglia esterna che loro stessi non riuscivano a mantenere.

Pochi, pochissimi, hanno raccontato un successo duraturo nato da uno di questi tentativi. La maggior parte mi ha detto la stessa cosa, in parole diverse: per un po' ha funzionato, poi è tornato tutto come prima. E di solito, nella seconda parte di quello che mi raccontano, c'è una nota che riconosco subito, perché la sento ripetere da uomini diversi con una frequenza che ormai ha smesso di stupirmi: dopo il tentativo fallito si sta peggio di prima.

Se è successo anche a te voglio dirti una cosa chiara, subito, prima di andare avanti, non è successo perché sei debole, non è successo perché hai poca volontà, non è successo perché sei una persona di serie B rispetto a chi c'è riuscito. È successo perché stavi affrontando il sintomo, non il meccanismo.

Il sintomo è il comportamento, cioè l'uso. Il meccanismo è tutto quello che ti ho mostrato nella Parte precedente: il trigger che non è mai solo erotico, la funzione di regolazione emotiva che il sistema nervoso chiede a quel comportamento, il sollievo chimico breve, la vergogna che ingrossa il trigger della volta successiva. Togliere il sintomo senza aver capito

il meccanismo è come abbassare la febbre senza aver trovato l'infezione. La febbre torna, a volte più alta della prima. E torna con un'informazione nuova, peggiore di quella con cui avevi iniziato: adesso sai anche di non essere riuscito a tenerla bassa.

Questa parte quindi serve a fissare un punto solo. I tuoi tentativi falliti non sono la prova di un difetto tuo. Sono il sintomo di un approccio che, da solo, sul porno contemporaneo, di solito non basta. Nella pagina che segue ti mostro perché.

Quando l'astinenza diventa un obiettivo morale

Negli ultimi quindici anni è cresciuto, in modo silenzioso ma molto vasto, un sottobosco di comunità online che propongono programmi di astinenza forzata dalla pornografia. I nomi cambiano, la logica è la stessa. Ci si iscrive a una comunità, si contano i giorni, si condivide il conteggio con altri, si ricomincia da zero se si ha un episodio di uso. Nella terminologia di quelle comunità, il giorno uno dopo un episodio si chiama reset. Il periodo di astinenza si chiama reboot. L'episodio stesso si chiama relapse, e in questo termine c'è già quasi tutto quello che voglio dirti in questa pagina.

Se anche tu hai pensato a te stesso in termini di "giorno 30" o "giorno zero" non c'è niente di cui vergognarsi. È il lessico che avevi a disposizione, ed è anche il lessico che ti ha tenuto compagnia quando non ne avevi un altro.

Gli uomini che si rivolgono a quel tipo di comunità ci arrivano con una motivazione sana. Vogliono riprendere controllo. Si sentono soli e cercano uno spazio in cui non esserlo. Trovano una struttura, un linguaggio, un'appartenenza. Tutte queste sono cose legittime, e in certi momenti della vita sono anche cose salvifiche. Non c'è niente di ridicolo o di debole nell'aver fatto quel tentativo. Molti dei miei pazienti lo hanno fatto, e la cosa non li abbassa ai miei occhi di un millimetro.

Il problema quindi non è la motivazione: è il meccanismo implicito del metodo.

Nel 2023 due ricercatori, Prause e Binnie, hanno pubblicato uno studio preregistrato sugli effetti di questi programmi. I risultati sono complessi da leggere ma, su un punto, molto chiari. Nei partecipanti a programmi di astinenza strutturata dalla pornografia, una maggiore aderenza al programma correla con peggiori indicatori di salute mentale. Detto in altre parole: quelli che ci stanno dentro di più, sul lungo periodo, stanno peggio. E, tra i partecipanti, una quota del 28,9% riporta ideazione suicidaria dopo un episodio di ritorno al comportamento. Non depressione vaga, non tristezza, non frustrazione. Ideazione suicidaria. È un dato che, da solo, cambia la conversazione su questo tipo di approccio.

Per capire come un metodo che si presenta come una liberazione possa produrre un dato del genere, bisogna guardare la meccanica del singolo episodio. Se il tuo obiettivo è contare i giorni, la tua identità inizia a poggiare sul conteggio. Tu non sei più un uomo che sta imparando qualcosa di sé. Sei uno che è arrivato a ottantasette giorni. La differenza, in astratto, sembra sottile. In pratica è enorme. Quando arriva l'episodio, e in quasi tutti questi percorsi arriva, quello che crolla non è più un comportamento. È una definizione di te. Ti senti tornato al giorno zero, la stessa persona di prima. Tutto quello che hai costruito è cancellato. E sotto questo pensiero, nel mondo reale, succede la cosa peggiore: la vergogna raddoppia, la vergogna diventa trigger, il trigger alimenta un nuovo episodio, spesso più lungo e più denso del precedente, e il ciclo che avevi letto nella Parte II si amplifica, non si spegne.

In psicologia clinica questa spirale ha un nome, lo si usa da decenni, ed è stato descritto in contesti molto diversi dall'uso di pornografia. Si chiama Abstinence Violation Effect. L'effetto di violazione dell'astinenza. È quello che succede quando un singolo evento viene interpretato come prova di un fallimento totale. È quello che, in uno studio qualitativo del 2021 (Fernandez e colleghi, Archives of Sexual Behavior), emerge come pattern centrale nei diari di astinenza che vengono scritti proprio nelle comunità online di cui ti parlavo.

La mia lettura è semplice. Un metodo che chiede di non avere nemmeno un episodio per non tornare al punto di partenza, in un campo in cui gli episodi sono frequenti, fa un lavoro molto preciso. Prende un comportamento già carico di vergogna e lo carica di altra vergogna. Non ti libera: ti ingabbia in modo più rigido.

Marco al secondo tentativo, e una posizione diversa sull'astinenza

Marco ci ha provato due volte prima di chiamarmi.

La prima volta è andato a quarantacinque giorni. Programma online trovato in rete, conteggio quotidiano, le prime due settimane di euforia, una parola sua: si sentiva *pulito*. Poi un venerdì pesante, un'ora vuota a casa da solo, e il laptop che si è aperto quasi senza che lui decidesse. Il lunedì mattina è rientrato nel conto al giorno uno, ma non era tornato al punto di partenza: stava peggio del punto di partenza.

Dopo un paio di mesi di silenzio interno ci ha riprovato. Stavolta novanta giorni. Dieci giorni in più dei famosi ottantasette di cui parlano in quelle comunità. Era orgoglioso, per davvero. Il novantunesimo giorno era un giovedì, e Marco era a Milano per un convegno di due notti. Camera d'albergo, solito finale. La caduta stavolta è stata lunga, tre settimane dense, un ritmo quasi quotidiano, e quello che ha fatto più danno non è stato l'uso in sé. È stata una

frase che si è ripetuto per ventuno giorni di fila, e che mi ha detto nella prima seduta, quasi piangendo, con un'espressione di ragionevole lucidità. "Evidentemente sono fatto così. Evidentemente è una cosa più grande di me".

La terza volta non ci ha provato. Non per pigrizia ma per intuito. Aveva capito, senza ancora saperlo dire a parole, che il problema non era resistere. Era capire.

Questa Parte finisce qui, con il box che segue. Leggilo lentamente.

COME USO IO L'ASTINENZA NEL LAVORO CLINICO

L'astinenza dalla pornografia non è l'obiettivo morale del percorso che faccio con i miei pazienti. È, quando serve, uno strumento diagnostico. Ti propongo di fermare il comportamento per un periodo definito quando abbiamo bisogno di vedere cosa succede al tuo corpo, alla tua sessualità con una partner reale, alle tue emozioni, nella finestra in cui quella variabile è assente. La osserviamo insieme, in seduta, con la stessa attenzione con cui si osserva un esperimento in laboratorio.

Mai "per sempre". Mai "finché non sarai guarito". Le durate sono definite prima, di solito in blocchi di trenta, sessanta o novanta giorni, e si rivalutano alla fine di ogni blocco, insieme. Se capita un episodio di uso durante il periodo, non azzera nulla. Non stiamo contando. Stiamo raccogliendo informazioni. L'episodio, nel mio quadro, è un dato, non un fallimento. È il punto in cui capiamo meglio dove sei vulnerabile, e dove quindi vale la pena guardare con più attenzione la volta successiva.

Non è un dettaglio di linguaggio. È la differenza che tiene in piedi il percorso o lo fa crollare.

Di questa differenza tra affrontare il sintomo e lavorare sul meccanismo, tra astinenza come obiettivo morale e astinenza come strumento diagnostico, ti riparerò in una delle email che ti arriveranno nei giorni dopo questa lettura. È una delle distinzioni più importanti del modo in cui lavoro, e ha senso che ti arrivi una seconda volta, da un'angolatura un po' diversa, proprio in una delle giornate in cui può capitare che il ricordo dei tuoi tentativi falliti torni a farti compagnia. Per molti degli uomini che ho seguito torna con forme diverse. Ma arriverà anche l'email, e in quella email ci sarà un pezzo di conversazione che proverà a disinnescare il giudizio che ti stai dando adesso, mentre leggi queste righe.

Parte IV — Cosa succede nel corpo

Perché il lavoro di sola testa, da solo, non basta

Nelle tre parti che hai letto fin qui ti ho parlato di meccanismo, di ciclo, di tentativi falliti. Tutto questo è lavoro di testa. Serve. Nella maggior parte dei percorsi terapeutici che funzionano, una parte di testa c'è, ed è quella che ti ha portato fin qui. Capire cosa ti sta succedendo è il primo atto terapeutico, non un preambolo.

E tuttavia, con il porno, la sola testa di solito non basta.

Ti spiego perché, con una frase che vorrei ti restasse. Il porno contemporaneo, come l'abbiamo descritto nella Parte II, è uno stimolo che insegna al sistema nervoso a slegare l'eccitazione dal corpo. Per molti uomini, dopo anni di uso intensivo, l'eccitazione è diventata un evento che accade sullo schermo, con la mano che compie un gesto quasi automatico, con il resto del corpo in una specie di parentesi. Il bacino fermo. Il respiro bloccato in alto, nel torace. La pelle poco sentita. Le gambe scaricate. L'attenzione tutta concentrata sugli occhi e sul palmo. È quello che in ambito clinico si chiama anche un tipo di dissociazione dal corpo, e non è una patologia rara, è quello che lo stimolo stesso allena, ogni volta. Non è colpa tua. È quello che quello stimolo fa, nel tempo, al sistema nervoso di chi lo usa con costanza.

Se questo è vero, allora un percorso che lavora solo sulla testa, solo sui pensieri, solo sulle credenze irrazionali, solo sulle catene di rinforzo, lascia intatta la parte del problema che sta nel corpo. Puoi capire tutto, e il corpo continuare a non ricevere il messaggio che qualcosa sta cambiando. Non perché la mente sia impotente, ma perché il corpo, su questo territorio, ha una sua memoria, più lenta e meno verbale.

Ecco perché nel lavoro che faccio con le persone che seguo, accanto alle tecniche cognitive entra una dimensione corporea. Consapevolezza del respiro. Radicamento nei piedi e nelle gambe. Attenzione alle sensazioni sottili del bacino, al diaframma, alla mascella, alle zone di tensione croniche. Piccole sequenze bioenergetiche mutate dalla tradizione di Alexander Lowen e dai suoi sviluppi contemporanei.

Il corpo, in questa storia, non è un accessorio. È un protagonista.

Un sistema che si ricalibra

Fatta la premessa di metodo entriamo nel merito di che cosa, nel corpo, sta succedendo veramente.

Immagina di avere, da qualche parte nel cervello, un sistema di ricompensa. Non un premio morale, una funzione biologica. Un circuito che, quando qualcosa di importante accade, si accende e ti dice: ecco, è qui, riconosci questo, ricordatelo, cerca ancora qualcosa di simile in futuro. Il sistema si è sviluppato per farci riconoscere ciò che ci serve per vivere: cibo buono, contatto con altri della nostra specie, calore, riuscita, sesso, sicurezza. Si accende davanti a queste cose, con intensità diverse, e poi si stabilizza, lasciandoti il desiderio di tornare, con moderazione, a quelle stesse fonti.

Ora immagina di prendere questo sistema e di esporlo, per vent'anni, a uno stimolo progettato per accenderlo più forte, più spesso, e con più varietà di qualunque fonte naturale. Uno stimolo che, ogni volta che compare, supera la soglia di intensità di qualunque evento reale ti capiti durante la settimana, tolto forse qualche momento di grande gioia o di grande stress.

Il sistema non si rompe. Non si spegne. Si adatta. Perché è proprio questo il suo mestiere: adattarsi.

Quello che succede è una ricalibrazione progressiva. Il termine di paragone interno, quello che il sistema usa per decidere cosa vale la pena accendersi, si sposta verso l'alto. Lo stimolo naturale, che prima bastava, inizia a sembrare poco. Il contatto reale, il cibo buono, la riuscita di una giornata, la conversazione con qualcuno che ami, continuano ad attivare il sistema, ma con intensità minore rispetto a prima. Non perché siano cambiati. Perché è cambiata la scala su cui vengono misurati.

Con il tempo il desiderio per la realtà si fa sempre più sottile.

Ma quello che vedo nei percorsi che tengo è ancora più interessante, e una buona notizia per te: il sistema ha una sua capacità di cambiare nel tempo anche al contrario. Si ricalibra su quello a cui lo esponi, giorno dopo giorno, e quando lo esponi a qualcosa di diverso, si ricalibra di nuovo. Non istantaneamente, non con un calendario uguale per tutti. Ma lo fa.

Se questo non avviene, il sistema si è ricalibrato su uno stimolo sovradimensionato. E tutto il resto, per un tempo, smette di bastare. Non perché tu sia rotto, ma perché hai insegnato al tuo sistema a misurare la realtà con un'unità di misura che la realtà non ha.

Quindi alla domanda se il sistema può ricalibrarsi di nuovo, la risposta breve è sì. La risposta lunga invece inizia alla pagina successiva.

PIED, cos'è, perché è reversibile

Tra gli uomini che arrivano da me per parlare di uso problematico di pornografia, una parte arriva con un altro problema collegato, che a volte dichiara subito e a volte confessa solo dopo qualche seduta. Non funziona con una partner reale. O non sempre. O all'inizio sì, e poi no. O sì da solo, ma non con lei.

Questo fenomeno ha un nome nella letteratura clinica di sessuologia, ed è la disfunzione erettile porn-induced, in inglese porn-induced erectile dysfunction, da cui la sigla PIED. È una disfunzione erettile in cui il corpo risponde alla pornografia, o alla fantasia di scene pornografiche, ma non risponde, o risponde poco e male, in presenza di una partner reale.

Voglio precisare una cosa, in modo netto, perché intorno a questo tema ho sentito troppi uomini raccontarmi di essere stati liquidati. Il PIED non è immaginario. Non è, nel senso dispregiativo, "tutto nella tua testa". È un fenomeno neurologico e comportamentale documentato, descritto in una revisione clinica importante di Park e colleghi nel 2016, discusso in letteratura da prospettive diverse, e soprattutto osservato in studio da chi lavora con questa popolazione. Che sia controverso nei dettagli di meccanismo non toglie che sia esperienza concreta, tua o di tanti altri.

E, cosa più importante di tutte, è reversibile.

Il motivo è la plasticità dello stesso sistema che ti ho appena descritto. Un sistema che si è ricalibrato per adattarsi a uno stimolo sovradimensionato può ricalibrarsi di nuovo, quando lo stimolo cambia. La ricalibrazione non è istantanea, non segue un calendario uguale per tutti, non è lineare. Ma è un processo osservabile e, nei casi che seguo, spesso tangibile nel corso di qualche mese.

Serve però una distinzione preliminare, e la devi fare con un andrologo prima ancora che con uno psicologo. La disfunzione erettile ha cause organiche vere: problemi vascolari, squilibri ormonali, farmaci, patologie neurologiche, abitudini metaboliche. Se l'andrologo, dopo una visita seria, trova qualcosa, quella è la via da percorrere.

Ma se l'andrologo, dopo una visita seria, ti dice che è tutto a posto, che i tuoi valori sono nella norma, che dal punto di vista organico non riesce a trovarti niente, e tu sai benissimo che qualcosa invece non funziona, non è che stai impazzendo. È che sei in un territorio specifico, che ha un nome, e che si tratta con strumenti specifici.

Su questo tema, quello del medico che ti rassicura ma il problema resta, torneremo in una delle ultime email che ti arriveranno dopo questa guida. È una delle conversazioni più frequenti che faccio nel primo colloquio, e merita uno spazio a sé. Per adesso ti basta sapere che il "è tutto ok" dell'andrologo non è la fine della storia, è un'informazione diagnostica: esclude una strada, e ci dà la possibilità di lavorare sulle altre.

Il flatline, e perché non si perde quasi mai per il flatline

C'è un fenomeno che vale la pena nominare adesso, perché se decidi di percorrere la strada con me, molto probabilmente lo incontrerai. Più probabilmente, lo incontrerai proprio nel momento in cui ti sarai fatto coraggio e avrai provato a fermare l'uso del materiale pornografico per un periodo.

Molti uomini che interrompono l'uso di pornografia per una o due settimane riferiscono una fase che descrivono, in parole diverse, sempre più o meno così. Il desiderio cala. Le erezioni spontanee, quelle del mattino, si riducono o scompaiono. Lo stato d'animo si fa piatto. A volte compare un senso di vuoto emotivo, di disinteresse generale, persino una nota depressiva leggera. La sensazione più frequente, nelle parole di chi la vive, è: mi sono rotto.

Nei forum online questo fenomeno è stato battezzato con un termine preso dall'elettrocardiogramma: flatline. Linea piatta. In quelle comunità, il flatline viene vissuto come prova che l'astinenza sta facendo danni, oppure, al contrario, come prova che l'astinenza sta funzionando e che bisogna resistere. In entrambi i casi, è un test da superare.

Nel mio approccio clinico il flatline non è un test. È un segnale.

Nella Parte III hai visto come Marco abbia interrotto il suo secondo tentativo proprio nella settimana in cui era entrato in flatline, interpretandolo come un test da superare. Il problema, per lui, non era stata la fase in sé. Era stata la lettura che le aveva dato.

Il segnale dice che il sistema di ricompensa, messo davanti alla scomparsa dello stimolo sovradimensionato su cui si era ricalibrato, sta rifacendo la sua misura. Sta cercando una nuova soglia. In questa fase, la sensibilità ai segnali naturali di desiderio e di eccitazione è temporaneamente abbassata, perché il sistema è nel mezzo di un aggiustamento. Non sei rotto. Sei in mezzo.

Quanto dura questa fase è soggettivo. Nei percorsi che seguo ho visto tempi molto diversi, da qualche settimana a qualche mese. Per questo non voglio farti una promessa del tipo "arriverà e poi passerà in tot tempo". La promessa sarebbe scorretta. Quello che posso dirti è che, quando il processo si completa, i segnali di ritorno esistono, e si riconoscono: ritorno

delle erezioni mattutine, ricomparsa di pensieri sessuali spontanei non scriptati, sensibilità corporea un po' più viva, interesse verso una partner reale se c'è.

C'è una cosa, però, che voglio sottolineare con precisione, perché è il punto clinico più importante di questa pagina. La maggior parte degli uomini che prova a fermare l'uso da solo, e poi torna al comportamento, non ci torna per il flatline. Ci torna per come ha letto il flatline.

Se leggi il flatline come fallimento, o come patologia, o come prova che sei rotto davvero, dentro di te succede una cosa precisa. La paura che quel vuoto sia permanente diventa insopportabile, e allora torni a controllare. Riaccendi lo schermo per verificare che almeno lì il corpo funzioni ancora. Scopri che in effetti risponde, e da un lato ti rassicuri, dall'altro sei già rientrato nel ciclo. Il problema non era la biologia del sistema. Era l'interpretazione che hai dato al fenomeno.

È per questo, e non per motivi astratti, che il lavoro su PPU e PIED, nel mio studio, non è mai un'astinenza solitaria. È un'astinenza accompagnata, con uno spazio di seduta dove il flatline si nomina insieme, si attraversa insieme, e non si trasforma in un test da superare davanti a uno specchio.

Nella pagina successiva ti racconto che forma ha un percorso.

Parte V — Le cinque domande di un percorso

Cinque domande, non cinque tappe

Nelle quattro parti che hai letto fin qui ho cercato di mostrarti un meccanismo, non una decisione. Se sei ancora con me, è perché qualcosa di quello che hai letto ti ha toccato. A questo punto è probabile che stia emergendo una domanda nuova, che non c'era all'inizio: esiste una forma di lavoro che tenga insieme tutto questo, e se sì, come si fa?

Nel mio studio lavoro su PPU e PIED seguendo un percorso strutturato che in media dura otto mesi. Ha una struttura clinica precisa, con fasi e criteri, e quando il lettore diventa paziente quella struttura la condivido per intero, nel primo colloquio, perché un percorso senza mappa non si affronta.

Te la traduco in cinque domande.

Non sono cinque tappe da attraversare in ordine rigido, non sono un elenco di cose da fare. Sono le cinque domande a cui un percorso serio, prima o poi, risponde. Di solito in quest'ordine, anche se non sempre. E sono, soprattutto, cinque domande che tu, che sei arrivato fin qui, stai già iniziando a formulare con parole tue, magari senza averle ancora messe a fuoco.

Come faccio a smettere?

È la prima domanda, perché è la prima urgenza. Quando si arriva da me, questa è quasi sempre la frase che si consegna all'inizio. Smettere, o almeno ridurre. Avere finalmente qualcosa che funzioni nelle ore vulnerabili: il venerdì sera, la camera d'albergo, la notte dopo una discussione, la domenica pomeriggio con casa vuota.

La risposta al primo bisogno è concreta e non glamour. Serve un sistema di osservazione del comportamento che diventa strumento di cura, non esame. Servono strategie per attraversare l'impulso senza agirlo, che all'inizio sono semplici e quasi poco interessanti: un modo per dare tempo all'urgenza di salire, toccare il picco, scendere. Servono modifiche leggere dell'ambiente digitale, di quelli che ho chiamato moltiplicatori di supernormalità,

per ridurre la soglia zero tra desiderio e soddisfazione. E serve, sempre, un posto dove nominare tutto questo con qualcuno che non si spaventa e non giudica.

Questa è la parte del percorso che un lettore impaziente potrebbe chiamare la parte pratica. Non lo è. È la parte fondativa. È il fondo su cui si costruisce tutto il resto, perché finché il comportamento non ha uno spazio in cui essere osservato invece che subito, nessun altro lavoro regge davvero.

Dietro il sintomo, dentro di te

Perché proprio questo?

È la domanda che arriva quando la prima si è un po' quietata. Una volta che l'urgenza ha smesso di essere l'unica cosa a cui pensi, si apre lo spazio per una curiosità diversa. Perché proprio questo, e non altro. Perché la pornografia, per te, a quest'ora, con queste emozioni. Perché non corse nel parco, non alcol, non lavoro, non fumo, non chiusure silenziose. Proprio questa cosa qui.

Ogni comportamento che si ripete risponde a una funzione. La parola tecnica è analisi funzionale. Dietro il sintomo, in altre parole, c'è sempre un compito emotivo che quel comportamento svolge per te. Può essere la regolazione di uno stato di agitazione che non sapresti dove altro scaricare. Può essere l'evitamento di un vuoto che, nominarlo, costerebbe troppo. Può essere un rifugio da una intimità coniugale che è diventata complessa. Può essere il sostituto di un contatto corporeo che manca, e che, da tanti anni, lo schermo ti sta offrendo nella sua versione più facile e più gratuita.

Finché non rispondi a questa domanda, il comportamento può cambiare forma, spostarsi di tre gradi, darsi aria di essere risolto, e poi tornare, identico. A volte torna sotto un'altra maschera, il che confonde ancora di più. Rispondere a questa domanda non vuol dire trovare un colpevole nel passato. Vuol dire riconoscere il compito che si è affidato al sintomo, e iniziare a chiedersi se quel compito, oggi, ha davvero bisogno di essere svolto così.

Chi sono quando non ho questa via di fuga?

Questa è, per molti uomini, la domanda più scomoda. La si affronta solo dopo aver camminato un po' nelle prime due, perché richiede fondo sotto i piedi.

Il porno, per molti, è il modo che hanno di stare con emozioni che non sanno abitare in un altro modo. Noia, stanchezza, rabbia silenziosa, solitudine con dentro casa, fallimento percepito, paura di non bastare. Quando quello spazio viene a mancare, anche solo in parte, emerge qualcosa che prima non si vedeva. Uno stato d'animo che bussa. Un ricordo che

riaffiora. Una tensione che era lì da anni e che era tenuta insieme, senza saperlo, da quella stessa via di fuga serale.

Il lavoro su questa domanda non consiste nel toglierti le emozioni scomode. Consiste nell'insegnarti a starci dentro senza esserne travolto e senza evitarle. Sono due abilità distinte, che in molti casi non sono mai state davvero allenate. Chi ha avuto la pornografia come regolatore invisibile di stati emotivi, per molti anni, spesso non ha sviluppato quei muscoli, non perché gli mancasse la capacità, ma perché c'era già qualcosa che svolgeva il compito al posto suo.

È la parte del percorso che cambia non solo il comportamento, ma il modo in cui tu stai con te stesso.

Il corpo e il tempo che viene

Come torno nel corpo?

Nella Parte IV ti ho detto che il porno, per anni, insegna al sistema nervoso a slegare l'eccitazione dal corpo. La quarta domanda è la conseguenza diretta di quella frase. Una volta che il sintomo è più governabile, e la sua funzione più leggibile, resta il problema pratico di come si torna a sentire.

Non è una domanda retorica. È una domanda sensoriale. Come si ricostruisce la capacità di lasciare che una sensazione salga nel bacino senza che la mente corra subito in un'altra stanza. Come si ri-educa l'attenzione a stare con la lentezza di un contatto reale, che non è mai intenso come un montaggio di scene selezionate da un algoritmo. Come si riabita la sessualità come esperienza di due corpi presenti, quando si è passati molto tempo come un occhio e una mano davanti a uno schermo.

Questa è anche la fase in cui il partner, se c'è, rientra pienamente nella scena. Non come test della guarigione, non come prova che qualcosa funziona. Rientra come altro corpo con cui ri-conoscersi, da capo, spesso dopo un lungo periodo in cui anche per la relazione il sesso era diventato una zona di imbarazzo. È la fase più lenta e, nelle mie osservazioni, una delle più sorprendenti, perché chi la attraversa di solito non si aspettava che la sessualità potesse cambiare qualità, non solo frequenza.

Come non ricado quando sarò solo?

È l'ultima domanda, e suona diversa dalle altre. Ha dentro una parola che, a questo punto, pesa in un altro modo: ricado.

Non è la domanda di chi teme la ricaduta come catastrofe morale. È la domanda di chi ha camminato abbastanza da capire che il percorso terapeutico, prima o poi, finisce. L'obiettivo dell'ultima fase non è prometterti che non ricadrà mai più. Quell'obiettivo non sarebbe clinico, sarebbe pubblicitario. L'obiettivo è che tu abbia imparato a riconoscere i segnali precoci, a sapere che cosa fare nei giorni più vulnerabili, a mantenere una rete, anche minima, di persone o pratiche a cui puoi tornare nei momenti opposti agli altri. Se capita un episodio, nella cornice di un percorso che ha attraversato le quattro domande precedenti, è un evento leggibile, non l'azzeramento di tutto.

È anche la domanda che, in seduta, segna la fine del lavoro comune. La prima volta in cui te la poni senza ansia è, nella mia esperienza, uno dei momenti più veri di un percorso intero.

Queste cinque domande non sono, nei casi che ho seguito, cinque caselle che si spuntano in ordine. Sono lo scheletro che tiene insieme otto mesi, in media, di conversazione. A volte si resta a lungo su una sola. A volte la risposta a una più avanti cambia la risposta a una precedente. A volte una domanda riemerge quando la credevi chiusa, e in quella nuova apparizione diventa più sottile. Di come, in concreto, queste domande si attraversano dentro una seduta, quale forma assumono quando diventano dialogo e non paragrafi, te ne parlerò in una delle prossime email che ti arriveranno dopo questa guida.

Alla pagina successiva, invece, cambio ancora registro. Ti consegno tre azioni semplici che puoi iniziare domani, senza aspettare nessun percorso, e che hanno un compito preciso: aiutarti a rivelarti quello che già hai sotto gli occhi, anche se in questo momento non lo vedi.

Parte VI — E adesso cosa faccio

Tre azioni che non sono terapia

Ti avevo detto, alla fine della pagina precedente, che alla pagina successiva avrei cambiato registro. Eccoci.

Nelle prossime due pagine trovi tre cose da fare. Tre azioni brevi, ragionevoli, che puoi iniziare domani mattina, o stasera, senza aspettare di aver preso una decisione più grande. Voglio essere molto chiaro, prima di metterle in fila, su una cosa: queste tre azioni non sono terapia. Non sono un metodo di autocura. Sono esperimenti di osservazione. Il loro compito è farti vedere con più precisione quello che già hai davanti agli occhi, in un territorio, quello delle tue ore vulnerabili, che di solito attraversi in automatico.

Il motivo per cui te le consegno qui, e non come pezzo finale di un percorso clinico, è che hanno un limite preciso che le rende innocue. Non ti chiedono di smettere. Non ti chiedono di fare promesse. Non ti chiedono di dimostrare niente a nessuno, te incluso. Ti chiedono solamente di guardare.

Per lo stesso motivo, però, queste tre azioni da sole non bastano. Il loro lavoro è portarti più informazioni su di te. Cosa farne, dopo, è una decisione successiva.

Qualcuno di quello che segue ti sembrerà ovvio. Quasi tutti gli uomini che l'hanno fatto sul serio, nel mio studio, mi hanno detto a fine settimana la stessa cosa: le idee erano ovvie, le scoperte no.

Osservare, mettere attrito, uscire dal silenzio

Osserva il ciclo

Per una settimana, a partire da oggi, prendi mentalmente nota di tre cose ogni volta che usi. Non serve un diario scritto, anche se se te lo vuoi scrivere va benissimo. Servono tre osservazioni, sempre le stesse.

La prima: cosa stava succedendo nell'ora che ha preceduto l'uso. Non nel generale della giornata, nell'ora prima. Una riunione tesa, una telefonata di casa, un silenzio con tua moglie

che non sapevi come aprire, una notifica, un pensiero che si era fatto insistente, un corpo stanco in un modo strano.

La seconda: come ti sentivi, in una parola, in quell'ora. Irritato, solo, svuotato, adrenalinico, anestetizzato, annoiato, troppo pieno. Una parola sola. Quella che, se stasera ti chiedessi di sceglierla a bruciapelo, sceglieresti.

La terza: cosa hai sentito subito dopo, nei cinque minuti dal termine. Solievo che dura poco, pesantezza, vuoto, irritazione con te stesso, niente. Non è il bilancio della serata. È cosa arriva immediatamente dopo.

Sette giorni bastano quasi sempre per far emergere il pattern. La maggior parte degli uomini che ho seguito, a fine della prima settimana, torna in studio con una riga che suona più o meno così: *ho capito che non è mai davvero per il sesso*. Non c'era scritto da nessuna parte. Era sotto gli occhi, tutti i giorni, da anni. Osservare, qui, non vuol dire altro che riaccendere la luce in una stanza in cui ti muovevi al buio.

Metti attrito tra desiderio e uso

Non ti sto chiedendo di bloccare tutto. Non ti sto chiedendo di installare filtri, di consegnare il telefono alla partner, di fare voti. Ti sto chiedendo un esperimento più piccolo e più utile, per due settimane.

Individua le due o tre situazioni in cui il tuo uso è più automatico, cioè quelle in cui la tua mano si muove prima che la tua testa abbia deciso qualcosa. Per molti è il telefono accanto al letto, la notte. Per altri è il browser già aperto in camera quando la porta si chiude. Per altri ancora è l'ultima ora prima di addormentarsi, sul divano, con la casa che ha smesso di fare rumore.

Scegli quelle due o tre situazioni, e per quattordici giorni aggiungi un pezzo di attrito. Il telefono non in camera, ma in cucina. Il browser non più già aperto, da aprire ogni volta daccapo. Il divano della sera sostituito, in quell'ultima ora, da una doccia, un libro, una telefonata, dieci minuti all'aria fuori di casa.

L'attrito non è astinenza. È solo un piccolo muro tra il tuo desiderio e la sua soddisfazione, abbastanza basso da essere superabile se serve, abbastanza alto da rendere il gesto non più automatico. Anche qui il lavoro utile non è non usare. È vedere quante volte scavalchi il muro, e in quali momenti. Il muro non è lì per fermarti. È lì per farti contare i passaggi.

Rompi l'isolamento

Questa è l'azione più trascurata, e nei casi che ho seguito è anche quella che sposta di più, con meno fatica apparente. Il ciclo che ti ho descritto in Parte II prospera nel silenzio. Si nutre della certezza che nessuno deve sapere.

Non ti sto chiedendo di dirlo a tua moglie. Non oggi, non sulla base di una guida che stai leggendo di nascosto. Ti sto chiedendo, entro la prossima settimana, di far uscire l'informazione da te in una forma qualunque, anche piccola.

Può essere un file di testo sul computer, dentro una cartella protetta da password, dove scrivi per venti minuti, senza rileggere, quello che ti sta capitando. Può essere una mail indirizzata a te stesso, scritta stasera e spedita stasera. Può essere una telefonata a un amico di cui ti fidi davvero, una di quelle poche persone che hai nella rubrica sapendo che una cosa detta a loro non ti tornerà indietro. Può essere, se ti senti pronto, il primo colloquio con me.

La forma conta meno del principio. Il principio è che un'informazione che fino a oggi viveva solo dentro la tua testa esca, in qualche modo, da lì dentro. Questo, tecnicamente, non risolve il problema. Ma toglie al problema uno dei suoi ingredienti più attivi, che è il segreto.

Cosa arriva dopo, e Marco a otto mesi

Cosa aspettarti nelle prime due settimane

Quando le persone che seguo arrivano a questo punto, di solito mi riportano tre eventi in sequenza, e probabilmente le sentirai anche tu.

Nei primi giorni senti una sorta di euforia leggera. Non gioia, una cosa più sottile, simile al sollievo di aver dato un nome a qualcosa che girava da tempo senza nome. Alcuni dormono meglio quelle prime notti. Altri hanno una mattina di lucidità mai avuta prima. Questo fa piacere, ma è la fase più ingannevole, perché fa credere che la lettura, da sola, abbia già fatto il lavoro.

Tra il settimo e il quattordicesimo giorno, più o meno, le cose cambiano. Torna il trigger, e insieme al trigger torna una voce che di solito suona così: *in fondo non era poi così grave, forse ho esagerato, forse quel tizio che ha scritto la guida stava facendo un po' il drammatico*. Questa voce ha un nome, te l'ho già detto a fine Parte I, si chiama minimizzazione. È una resistenza così prevedibile che se non la incontri in quei giorni vale la pena chiedersi se non stai facendo finta di non sentirla. Se invece la incontri, sappi che è il segno che la guida sta lavorando, non il segno che non ha funzionato.

Poi nel corso della seconda settimana inizia a farsi sentire qualcosa di più sostenuto. Non è depressione. Non è crisi. È l'assenza di un riempimento automatico che per anni c'era sempre stato. È un vuoto relativo, che si presenta per mezz'ora alla sera, o al risveglio, o dopo una riunione. Questa è la fase in cui, da soli, quasi tutti tornano al comportamento. Non per debolezza. Perché non hanno nessuno con cui stare dentro a quel vuoto e poterlo attraversare senza doverlo riempire subito. È per questo che il lavoro clinico serio, in questo campo, non è fatto di tecniche. È fatto di una relazione dentro cui certi vuoti diventano percorribili.

Marco a otto mesi

Torno a Marco un'ultima volta, e poi lo lasciamo andare.

Oggi, a otto mesi dal suo primo colloquio, Marco non ha smesso. Ha ridotto. Il comportamento che occupava quasi tutte le sue sere libere è diventato un episodio sporadico, ogni tre o quattro settimane, a volte più raro, a volte meno. E' un cambio di rapporto con una cosa che è ancora lì. Prima era il centro di gravità delle sue serate. Adesso è un peso che ogni tanto riemerge e che lui sa, per lo più, come attraversare senza finirci dentro.

Alla moglie ha parlato. Non di tutto, non in blocco, non in una scena drammatica tipo quelle dei film. Le ha detto abbastanza perché una parte del silenzio uscisse di casa, e abbastanza poco perché lei non dovesse ricevere in un colpo solo quindici anni di nascondimento. Hanno attraversato qualche settimana strana. Poi, lentamente, il rapporto sessuale fra loro è tornato a funzionare, dopo più o meno quattro mesi dall'inizio del nostro lavoro. Non subito. Non grazie a un trucco. Grazie a una ricostruzione che ha riguardato tutti e due, non solo il sintomo di lui.

Non userei la parola felicità per descrivere come sta Marco oggi. Userei la parola libertà, con i limiti che ha. Marco è libero nel senso stretto del termine: ha più margine di scelta davanti a un impulso di quanto ne avesse otto mesi fa. Non è una libertà assoluta. È la libertà possibile per un uomo di quarantadue anni che per quindici anni ha messo in automatico una cosa molto grande, e che sta imparando, in una stanza, a guardarla.

Se la storia di Marco non ti sembra una storia di successo spettacolare, bene. Non lo è. Le storie di successo spettacolare, in questo campo, di solito sono marketing.

Nella pagina che segue affronto un caso che potrebbe essere il tuo, e che finora ho tenuto fuori dal cuore della guida per non mischiarlo con quello che hai letto finora. È il caso di chi ha riconosciuto qualcosa in queste pagine, ma non tutto, e in particolare si sta chiedendo se il porno, per lui, sia davvero il punto.

Parte VII — Ponte: e se il porno con me non c'entra?

Se con te il porno non c'entra davvero

Può darsi che leggendo queste pagine tu abbia pensato, in un punto o in un altro, una cosa sincera: *questo non è il mio problema*. Tu il porno, se lo usi, lo usi in un modo che ti somiglia. Niente doppia vita, niente settimane intere passate a farti domande su quanto resti prima di aprire il browser, niente escalation che ti abbia mai spaventato. Però una disfunzione ce l'hai. Oppure un'ansia che ti si accende a ogni incontro e che ti sta facendo evitare le occasioni. Oppure un desiderio che da mesi non torna, e non sai perché. E con te, onestamente, il porno non c'entra.

Se ti stai dicendo qualcosa del genere, hai ragione a chiederti se questa guida fa davvero per te. Ti risolvo il dubbio in due pagine, con la stessa chiarezza con cui ti ho tenuto compagnia fin qui.

La domanda "il porno c'entra o non c'entra" non è una questione di sensibilità personale o di come ti racconti la tua storia. È una domanda clinica, con risposta riconoscibile, e con criteri che puoi applicare a te stesso in pochi minuti. Te ne elenco quattro, in ordine di utilità. Non sono un test da compilare. Sono quattro finestre che ti aiutano a vedere da che parte, probabilmente, è il tuo problema.

La frequenza d'uso

Un uso di pornografia occasionale, diciamo settimanale o più raro, con interi periodi in cui non ti passa neanche dalla testa, di solito non è il motore di una disfunzione erettile o di un calo di desiderio. Quando il porno è il driver clinico, il consumo tende a essere regolare, costante, ritagliato in momenti fissi, e con meccaniche di spinta riconoscibili dall'interno. Se il tuo uso è basso e intermittente, e il sintomo sessuale è stabile o peggiora, le due cose probabilmente viaggiano su binari separati.

L'uso solitario contro l'uso condiviso

Quando usi, lo fai esclusivamente da solo e in un contesto nascosto, oppure capita che lo faccia anche in coppia, come parte integrata del vostro gioco? Un uso condiviso, negoziato, che entra nella relazione, non produce quasi mai gli squilibri descritti nelle Parti precedenti. L'uso problematico ha una firma quasi sempre solitaria, silenziosa, ritagliata in spazi dove sei sicuro di non essere visto. Se il tuo uso non ha questa firma, è un segnale a favore dell'ipotesi che il porno non sia il punto, per chi dobbiamo indagare su altro.

Il grado di dissociazione durante l'atto

Quando usi, dove sei? Sei dentro al tuo corpo, con una presenza alle sensazioni e un tempo che ti appartiene? Oppure sei in una specie di autopilota lucido, guardandoti da fuori, con poco contatto con quello che il tuo corpo sta effettivamente sentendo? La dissociazione corporea durante l'uso è uno dei marker più affidabili del meccanismo compulsivo. Se sei prevalentemente dentro di te, con piacere registrato e un ritmo a tua misura, stai descrivendo un uso funzionale, non il ciclo che hai letto in Parte II.

Il funzionamento solitario rispetto al funzionamento con partner

È il criterio più tecnico, e anche il più rivelatore. Se da solo il corpo risponde pienamente, ma con una partner reale non risponde o risponde poco, siamo con buona probabilità nel territorio del PIED, o in un territorio limitrofo in cui un certo tipo di stimolazione ha insegnato al sistema nervoso ad accendersi solo in quelle condizioni. Se invece la difficoltà c'è anche in solitudine, o se c'è anche senza alcuna stimolazione pornografica, il meccanismo è altrove. Va cercato altrove.

Tre scenari clinici, e cosa puoi fare da adesso

Se i quattro criteri ti hanno orientato verso l'ipotesi che il porno non sia il punto, vale la pena che tu abbia in testa tre scenari tra i più frequenti, in cui uomini della tua fascia di età tipicamente rientrano. Te li passo in forma essenziale, per aiutarti a nominare quello che potrebbe stare succedendo.

Il primo è la **disfunzione erettile psicogena non-porn**. Nasce dentro la vita, non dentro lo schermo. Spesso parte da un episodio: una sera in cui il corpo, per stanchezza, per stress, per una conversazione non risolta con la tua compagna, non ha risposto come ti aspettavi. Quel singolo episodio, se è stato letto come il segnale di qualcosa di più grande, è diventato il seme di un'aspettativa catastrofica che si riattiva in ogni situazione sessuale successiva.

Attivando l'allarme, spegne la risposta. Nessun porno in mezzo. Solo un corpo che ha imparato troppo bene a proteggersi da un pericolo che non c'è.

Il secondo scenario è l'**ansia da prestazione isolata**. Somiglia al primo, ma è più chirurgica. Non c'è necessariamente una storia relazionale dietro, o se c'è non è il fattore dominante. C'è un pensiero specifico, che si presenta puntuale all'ora dell'atto, e che ha una voce riconoscibile: *stavolta non funzionerà, lei se ne accorgerà, sarà un disastro*. Quel pensiero produce uno stato di iper-controllo, e l'iper-controllo, nel sesso, è la cosa meno compatibile con il funzionamento del corpo che si possa immaginare. Qui il porno è innocente. Il problema è un pensiero che ha imparato a presentarsi sempre alla stessa ora, e un corpo che ha imparato a rispondergli sempre allo stesso modo.

Il terzo scenario è il **calo di desiderio su base sistemica**. È quello che più spesso arriva nello studio senza essere nominato come problema sessuale, perché sembra altro. Una fatica cronica che dura da mesi e che non passa con le vacanze. Un conflitto con la partner che è lì da tempo, non detto o detto male, e che ha spento una parte del desiderio senza che te ne accorgessi. Un umore che si è appiattito senza che tu l'abbia chiamato depressione, ma che funziona esattamente come una depressione sotto soglia. In questo terzo scenario la sessualità è il sintomo, non la sede del problema. Se provi a lavorare solo sulla sessualità, non cambia niente, perché il motore è altrove.

Per questi scenari sto preparando una guida separata. Se hai lasciato l'email, la riceverai quando sarà pronta. Nel frattempo, se ti riconosci più qui che nelle pagine precedenti, non fermarti. Scrivimi direttamente a ivan@ivanferrero.it dicendomi in una riga cosa ti succede. È la via più breve per sapere, insieme, se posso esserti utile.

Parte VIII — Passaggio di testimone

Sei arrivato fin qui

Sei arrivato fin qui. Ti faccio i miei complimenti: non è una lettura veloce, e tanto meno una lettura facile.

Quando hai lasciato la tua email per ricevere queste pagine, senza saperlo hai detto una cosa a te stesso, e solo dopo a me. Hai detto che eri disposto a guardare, almeno per un attimo, una cosa che fino a ieri avevi preferito non guardare. Si è aperto un varco, e il minimo che posso fare è tenerti compagnia dopo che l'hai aperto, nella forma di qualcuno che conosce bene il terreno su cui stai per camminare, e che sa cosa ti troverai sul percorso.

Nelle prossime tre settimane ti scriverò sei volte. Ti scriverò perché, dopo una lettura come questa, di solito succedono alcune cose specifiche. Le ho viste succedere tante volte, con uomini diversi, in studi diversi, in età diverse. Non sono profezie. Sono traiettorie frequenti, e nelle settimane in cui si presentano una per una, avere qualcuno che te le nomini prima che ti travolgano cambia completamente cosa ci fai.

E una volta che hai riconosciuto queste traiettorie sei già in vantaggio rispetto al problema.

Nei primi giorni dopo la lettura di questa guida capita spesso che una voce interna si faccia sentire, leggera, ragionevole, quasi sollevata. Ti dirà che forse non era così grave, che ti sei riconosciuto troppo, che puoi chiudere qui. È la prima delle resistenze, la più prevedibile e la più depotenziante se la prendi per vera. Di quella voce ti scriverò per primo.

Poi, di solito, torna il ricordo di una volta in cui avevi già provato a smettere da solo, e non era andata come volevi. Con quel ricordo arriva l'idea, vecchia, secondo cui il problema sia il tuo carattere. Su questo punto ho molto da dirti, e torneremo su una differenza che nella Parte III avevo solo accennato: quella tra affrontare il sintomo e affrontare il meccanismo. Ti racconterò anche perché il mio modo di lavorare non chiede a nessuno di "resistere".

Nei tempi immediatamente successivi, se sei sposato o convivi con qualcuno, inizia a farsi più pesante una domanda che probabilmente sta già galleggiando sopra al resto. Chi sa, chi non sa, quanto devo dire, a chi, e come. Qui sbagliano in tanti, perché la paura di esporsi spinge a scelte estreme in entrambe le direzioni: rivelare tutto subito oppure non rivelare

mai. Nessuna delle due è di solito la risposta. Di questa domanda ti parlerò con la cura che merita, perché dentro c'è il matrimonio, ci sono i figli, e ci sei tu.

A quel punto inizierà a farsi sentire un'altra voce. Quella che si chiede se questo mio modo di lavorare abbia davvero senso clinico e dei risultati, o se io sia soltanto uno dei tanti che promettono qualcosa. È una domanda sacrosanta. Per questo ti mostrerò da dentro come lavoro: cosa accade nelle prime sedute, come si articola un percorso nei suoi mesi, che aspetto hanno le fasi che in queste pagine ho solo accennato come cinque domande. Niente brochure, niente garanzie. Solo l'onestà di farti vedere in cosa ti staresti mettendo se decidessi di mettertici.

Poi, verso la fine della sequenza, tocca al tema che quasi nessuno vuole aprire per primo, e che puntualmente torna. Soldi, tempo, praticità. Te ne parlerò senza giri, con i numeri reali di quello che costa il mio lavoro, la durata media di un percorso, il tempo che chiede a un adulto che lavora e ha una famiglia. Perché le decisioni cliniche si prendono meglio con le informazioni in mano, non senza.

E alla fine, se sarai ancora lì, tre domande. Non filosofiche. Tre domande molto concrete, a cui si risponde in poche righe, e che servono a capire se, per te, è il momento. Se le tue risposte dicono di sì, ti proporrò un passo semplice, a basso impegno: una conversazione breve, al telefono, senza alcun obbligo di prendere me come psicologo. Quindici minuti per capire, insieme, se ha senso fare questo tratto di strada.

Se invece hai già capito che ti senti pronto a iniziare questo percorso, scrivimi a ivan@ivanferrero.it , oppure chiamami o mandami un messaggio (anche WhatsApp e Telegram) a questo mio numero di telefono: +39 3334339624 .

Grazie per essere arrivato fino a qui. Noi ci rileggiamo presto.

Dott. Ivan Ferrero Psicologo psicoterapeuta <https://equilibrio.ivanferrero.it/ivan@ivanferrero.it>

A P P E N D I C I

Appendici

Glossario minimo

Una riga per voce, senza pretesa tassonomica. Per chi vuole un ancoraggio veloce ai termini che ha incontrato in queste pagine.

Analisi funzionale. Procedura clinica con cui si osserva, insieme alla persona, cosa succede prima, durante e dopo un comportamento, per capire che funzione quel comportamento sta svolgendo nella sua vita (regolare un'emozione, evitare un pensiero, colmare un vuoto, scaricare tensione).

CSBD (Compulsive Sexual Behaviour Disorder). Disturbo da comportamento sessuale compulsivo, entrato ufficialmente nell'ICD-11 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Descrive un pattern persistente di difficoltà a controllare impulsi sessuali, con conseguenze funzionali significative. Non è sinonimo di "dipendenza sessuale" e non è ancora nel DSM.

Flatline. Termine di origine non clinica, nato nelle comunità online di astinenza, usato per descrivere la fase in cui, dopo aver interrotto un pattern di consumo intensivo, il desiderio sessuale si spegne temporaneamente. In chiave clinica è un segnale di ricalibrazione del sistema, non un fallimento e non una malattia.

Harm reduction. Approccio clinico che mira a ridurre i danni associati a un comportamento, invece di imporre come unico obiettivo l'astinenza totale. Si usa storicamente nelle dipendenze da sostanze e si applica, con gli adattamenti necessari, anche ai comportamenti compulsivi.

PIED (Porn-Induced Erectile Dysfunction). Disfunzione erettile in cui il corpo risponde agli stimoli pornografici ma non risponde, o risponde poco, nel contatto sessuale con un partner reale. Non è immaginaria e non è organica, è un'ipotesi di meccanismo comportamentale e neurologico discussa in letteratura da prospettive diverse.

PPU (Problematic Pornography Use). Uso problematico di pornografia. Descrive un uso che interferisce in modo significativo con il funzionamento quotidiano (lavoro, sonno, relazioni, umore) oppure che il soggetto fatica a modulare nonostante tentativi ripetuti. Non coincide con la frequenza in sé.

Supernormalità. Concetto preso a prestito dall'etologia (studio del comportamento animale). Uno stimolo supernormale è uno stimolo progettato, anche involontariamente, per superare in intensità gli stimoli naturali con cui il nostro sistema nervoso si è evoluto. La pornografia contemporanea, per disponibilità infinita e novità continua, ha molti tratti di stimolo supernormale.

Nota deontologica

Marco, il protagonista che hai incontrato in apertura, a metà della guida e verso la fine, è un caso composito. Questo significa che nessuna persona reale è riconoscibile nella sua storia. Ho costruito Marco mettendo insieme elementi ricorrenti di centinaia di percorsi clinici: l'età intorno ai quaranta, la professione qualificata, la vita coniugale con figli, i quindici anni di uso problematico, i due tentativi di reboot andati come sono andati, la moglie a cui a un certo punto si dice qualcosa ma non tutto. Nessuno di questi elementi è preso da una singola persona. Messi insieme raccontano un pattern che ho incontrato molte volte nella mia pratica, non una biografia.

Questa scelta risponde a un obbligo preciso. Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, agli articoli che regolano il rapporto con il pubblico e con i pazienti (in particolare articoli 38, 39 e 40), richiede che il materiale clinico sia utilizzato nella comunicazione pubblica solo quando è garantita l'impossibilità di identificazione, e con il rigore scientifico che il tema richiede. Il composito dichiarato è uno degli strumenti riconosciuti per fare informazione clinica senza venir meno a quell'obbligo.

Dal medesimo principio discendono due altre cose, che hai letto in forme diverse lungo la guida e che qui metto in chiaro senza giri.

Questa guida non costituisce una diagnosi. Nessuna domanda di auto-osservazione che hai incontrato nelle pagine precedenti fornisce un punteggio, una soglia, o un'etichetta clinica. La diagnosi è un atto professionale che richiede un incontro, più sedute, un'anamnesi, e una valutazione che tenga conto di molti elementi che un testo scritto non può raccogliere. La guida offre una mappa, non un territorio, e la mappa resta tale finché qualcuno non decide di camminarci sopra con me o con un altro collega qualificato.

Questa guida non promette risultati. Non troverai scritto da nessuna parte, in queste pagine, che la terapia "funziona", che "guarirai", che "ti libererai". Non lo scrivo perché non si può scrivere. La terapia seria lavora con probabilità, non con garanzie, e il rispetto per chi legge passa anche da questa onestà. Quello che posso dirti è che nelle persone con cui ho lavorato,

negli anni, di solito succedono alcune cose. Te le ho raccontate dove era rilevante farlo, con le cautele del caso.

Fonti essenziali

Selezione ridotta, pensata per chi vuole verificare o approfondire. Dove possibile i riferimenti sono peer-reviewed. Dove il testo è manualistico o non è sottoposto a peer-review, lo dichiaro in forma esplicita. Per una bibliografia più ampia, scrivimi.

Park, B. Y., Wilson, G., Berger, J., Christman, M., Reina, B., Bishop, F., Klam, W. P., & Doan, A. P. (2016). Is Internet pornography causing sexual dysfunctions? A review with clinical reports. *Behavioral Sciences*, 6(3), 17. Riferimento sul PIED e sulle possibili ricadute della pornografia ad alta disponibilità sulla risposta sessuale. Da leggere con cautela metodologica, come parte del dibattito aperto più che come prova definitiva.

Prause, N., & Pfaus, J. (2015). Viewing sexual stimuli associated with greater sexual responsiveness, not erectile dysfunction. *Sexual Medicine*, 3(2), 90-98. Voce critica rispetto a Park e colleghi, utile per tenere aperto il confronto scientifico.

Prause, N., & Binnie, J. (2023). Iatrogenic effects of Reboot/NoFap on public health: A preregistered survey study. *Sexualities*. Online first marzo 2023, volume formale 2024. DOI: 10.1177/13634607231157070. Studio preregistrato sugli effetti dei programmi di astinenza strutturata dalla pornografia, con indicatori di salute mentale peggiori nei partecipanti più aderenti al programma e quota significativa di ideazione suicidaria dopo episodi di ritorno al comportamento.

Fernandez, D. P., Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2021). Studio qualitativo sui diari di astinenza nelle comunità online di tipo reboot/NoFap, pubblicato su *Archives of Sexual Behavior*. Descrive il pattern dell'Abstinence Violation Effect applicato al consumo di pornografia.

Kraus, S. W., Voon, V., & Potenza, M. N. (2016). Should compulsive sexual behavior be considered an addiction? *Addiction*, 111(12), 2097-2106. Revisione bilanciata del dibattito tra modello addiction e modelli alternativi.

Kraus, S. W., Krueger, R. B., Briken, P., First, M. B., Stein, D. J., Kaplan, M. S., Voon, V., Abdo, C. H. N., Grant, J. E., Atalla, E., & Reed, G. M. (2018). Compulsive sexual behaviour disorder in the ICD-11. *World Psychiatry*, 17(1), 109-110. Documento di riferimento per l'ingresso del CSBD nell'ICD-11.

Grubbs, J. B., Perry, S. L., Wilt, J. A., & Reid, R. C. (2019). Pornography problems due to moral incongruence: An integrative model with a systematic review and meta-analysis. *Archives of*

Sexual Behavior, 48(2), 397-415. Meta-analisi chiave sul ruolo del conflitto morale nel determinare il distress associato al consumo.

Brand, M., Young, K. S., Laier, C., Wölfling, K., & Potenza, M. N. (2016). Integrating psychological and neurobiological considerations regarding the development and maintenance of specific Internet-use disorders. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 71, 252-266. Modello I-PACE, riferimento teorico per le dipendenze da internet.

Crosby, J. M., & Twohig, M. P. (2016). Acceptance and Commitment Therapy for problematic internet pornography use: A randomized trial. *Behavior Therapy*, 47(3), 355-366. Uno dei pochi studi randomizzati controllati nel campo, sull'efficacia di ACT.

Hook, J. N., Reid, R. C., Penberthy, J. K., Davis, D. E., & Jennings, D. J. (2014). Methodological review of treatments for nonparaphilic hypersexual behavior. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 40(4), 294-308. Revisione dei trattamenti con attenzione ai limiti metodologici della ricerca disponibile.

Lowen, A. (1975). *Bioenergetics*. Coward, McCann & Geoghegan. Riferimento manualistico non peer-reviewed, citato perché il framework terapeutico integra elementi di analisi bioenergetica (respiro, grounding, consapevolezza corporea). Testo fondativo della tradizione bioenergetica, di natura clinico-formativa.

Ogden, P., Minton, K., & Pain, C. (2006). *Trauma and the Body: A Sensorimotor Approach to Psychotherapy*. W.W. Norton & Company. Riferimento manualistico contemporaneo sull'integrazione tra approccio psicodinamico e lavoro somatico, di rilievo clinico consolidato e sostenuto da una letteratura empirica peer-reviewed in continua espansione. Pertinente per la dimensione corporea del framework.

Porges, S. W. (2011). *The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-regulation*. W.W. Norton & Company. Sintesi della Polyvagal Theory, paradigma neurobiologico di riferimento per il body-based work contemporaneo. Manualistica consolidata, con vasta base di articoli peer-reviewed dell'autore (cfr. Porges, S. W., 2007. The polyvagal perspective. *Biological Psychology*, 74(2), 116-143).

van der Kolk, B. (2014). *The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma*. Penguin Books. Riferimento manualistico di peso pubblico e clinico consolidato sul lavoro corporeo nella regolazione emotiva e nella ricalibrazione del sistema nervoso. Non strettamente bioenergetico, ma compatibile con il framework integrato di Equilibrio.

Privacy e contatto

Quando hai lasciato la tua email per ricevere questa guida, hai acconsentito a due cose distinte, e voglio ricordartele qui perché è giusto così. La prima è la consegna di questo PDF. La seconda è la sequenza di email di cui ti ho parlato nel passaggio di testimone, spalmata su circa tre settimane.

La tua email resta tra te e me. Non viene ceduta, non viene venduta, non viene condivisa con terze parti per finalità commerciali. La piattaforma tecnica che uso per inviare queste comunicazioni è conforme al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), e tratta la tua email come dato personale ai sensi di legge. Per la natura del tema, i dati legati all'iscrizione alla sequenza sono trattati come dati particolarmente sensibili ai sensi del GDPR, con le garanzie previste dalla normativa europea.

Puoi disiscriverti in qualunque momento. In fondo a ogni email che ti arriverà trovi un link di disiscrizione a un clic, senza domande, senza richieste di motivazione. Puoi anche scrivermi direttamente a ivan@ivanferrero.it dicendomi che vuoi uscire, e lo faccio io manualmente.

La privacy policy completa del sito, con i dettagli su base giuridica, periodo di conservazione dei dati, diritti dell'interessato e modalità di esercizio, è consultabile su <https://equilibrio.ivanferrero.it/> nella sezione dedicata.

Per qualunque domanda che riguardi questa guida, la sequenza di email, o il mio lavoro clinico, puoi scrivermi a ivan@ivanferrero.it. Ti rispondo io.

Dott. Ivan Ferrero Psicologo psicoterapeuta <https://equilibrio.ivanferrero.it/ivan@ivanferrero.it>